Valvulopathies : sémiologie et raisonnement clinique

Appareil cardio-vasculaire — Sémiologie — Version complète de référence

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (41 pages) ; prise de notes (17 pages, avec un passage manquant entre la fin de l'insuffisance aortique et le début de l'insuffisance mitrale)
Périmètre	Cours entier

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], **[Non abordé cette année]**, **[Dit à l'oral]**	indications de priorité reprises de la prise de notes.

Introduction (diapositives n°1 à 3)

Un **souffle cardiaque n'est pas anodin** : il peut conduire à une décision thérapeutique importante. Un patient peut réduire progressivement son activité sans se considérer comme malade : « Je ne monte plus les escaliers... mais c'est sûrement l'âge » peut révéler une **valvulopathie devenue symptomatique**. Le 1er enjeu de l'interrogatoire est de **repérer ce qui a changé dans la vie du patient**, notamment sa capacité à l'effort. **[Dit à l'oral]** Il faut parfois faire comprendre au patient, examens à l'appui, qu'il est malade.

Objectifs (diapositive n°3) : **reconnaître** (situer un souffle dans le cycle cardiaque), **expliquer** (relier l'obstacle ou la fuite à ses conséquences), **orienter** (choisir l'examen clé et repérer les situations urgentes). Pour chaque valve, on raisonne selon la séquence **mécanisme → souffle → retentissement**.

Partie 1 — Repères (diapositives n°4 à 10)

1.1. Les valves orientent le flux (diapositive n°4)

Les **valves atrioventriculaires** sont la **mitrale à gauche** et la **tricuspide à droite**. Les **valves artérielles** sont l'**aortique** (sortie du ventricule gauche) et la **pulmonaire** (sortie du ventricule droit). Les valves **s'ouvrent et se ferment selon les différences de pression**.

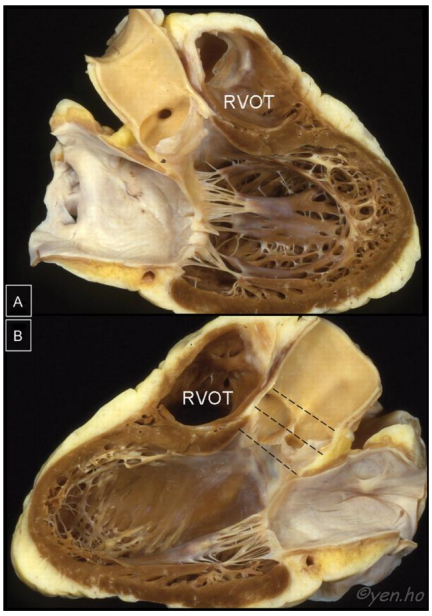


Figure — diapositive n°4

Description du schéma (diapositive n°4) : 2 coupes anatomiques d'un cœur disséqué (A et B) montrant le **ventricule droit** : sa paroi trabéculée, l'appareil de la **valve tricuspide** (feuillets et cordages tendineux) et la **chambre de chasse du ventricule droit** (notée RVOT, sous la valve pulmonaire).

1.2. Systole ou diastole ? (diapositive n°5)

Phase	Valves aortique et pulmonaire	Valves mitrale et tricuspide
Systole ventriculaire	Ouvertes pendant l'éjection	Fermées
Diastole ventriculaire	Fermées	Ouvertes pendant le remplissage

Le **1er bruit du cœur correspond à la fermeture des valves mitrale et tricuspide** ; le **2e bruit correspond à la fermeture des valves aortique et pulmonaire**.

1.3. Obstacle ou fuite : 2 mécanismes (diapositive n°6)

Lésion	Problème mécanique	Conséquence typique
Réduction de l'orifice (rétrécissement)	Le sang franchit un obstacle	Pression élevée en amont
Mauvaise fermeture (insuffisance)	Une partie du sang revient en arrière	Surcharge de volume

Le **rétrécissement aortique** crée une **surcharge de pression du ventricule gauche** (obstacle à l'éjection en systole), d'où une hypertrophie. Les **insuffisances aortique et mitrale chroniques** créent une **surcharge de volume** : du ventricule gauche pour l'insuffisance aortique, de l'oreillette gauche et du ventricule gauche pour l'insuffisance mitrale.

1.4. L'interrogatoire commence à l'effort (diapositive n°7)

On recherche la **capacité fonctionnelle** : escaliers, marche, sport, activités quotidiennes : qu'est-ce qui est devenu difficile ? Les **symptômes** à rechercher sont la **dyspnée**, l'**angor**, la **syncope ou le malaise** et les **palpitations**. Le **contexte** compte : fièvre, maladie valvulaire connue, antécédents familiaux, chirurgie valvulaire.

[Vigilance] Un patient « asymptomatique » doit être vérifié : il a pu réduire son activité pour éviter ses symptômes.

[Dit à l'oral] Un patient non sportif peut ne pas se plaindre et n'être vu qu'à un stade avancé, alors qu'une prise en charge précoce a un bon pronostic. Le patient arrive souvent en décompensation cardiaque (prise de poids, dyspnée), voire en insuffisance cardiaque causée par la valvulopathie ; traitée à ce stade, la récupération est moins bonne et plus longue.

[Insistance d'un intervenant] 2 associations de symptômes à savoir reconnaître : **dyspnée + angor + syncope ou lipothymie = rétrécissement aortique** ; **dyspnée + palpitations = insuffisance mitrale**.

1.5. Les souffles à reconnaître (diapositive n°8)

Lésion	Temps	Foyer et irradiation
Rétrécissement aortique	Systolique d'éjection	Foyer aortique, irradiant aux carotides
Insuffisance aortique	Diastolique, décroissant	Bord sternal gauche
Insuffisance mitrale	Souvent holosystolique	Pointe, irradiant vers l'aisselle
Rétrécissement mitral	Roulement diastolique	Pointe

Pour chaque souffle, on décrit le **temps**, le **foyer** et l'**irradiation**.

[Vigilance] On ne déduit pas la sévérité du volume sonore : un souffle peu intense peut accompagner une valvulopathie sévère.

1.6. L'échocardiographie répond à 3 questions (diapositive n°9)

Après l'interrogatoire et l'examen clinique, l'**échocardiographie transthoracique est l'examen de 1re intention devant une valvulopathie suspectée**. Elle répond à 3 questions : **pourquoi ?** (quelle valve, quelle cause, quel mécanisme) ; **quelle sévérité ?** (plusieurs paramètres concordants, et non la seule taille d'un jet) ; **quel retentissement ?** (ventricules, oreillettes, fonction cardiaque, pressions pulmonaires).

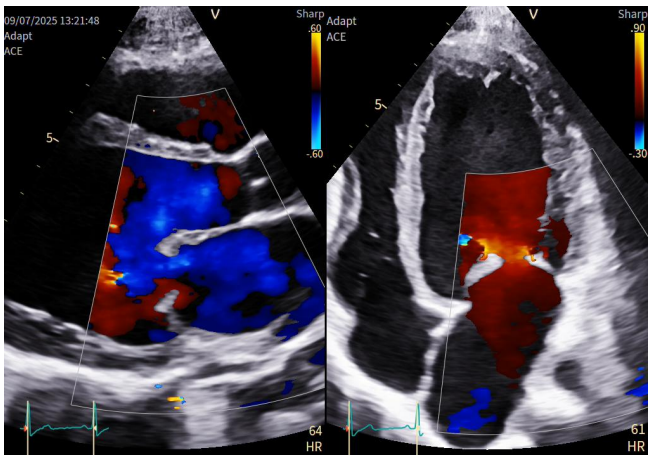


Figure — diapositive n°9

Description du schéma (diapositive n°9) : image d'**échocardiographie** avec **Doppler couleur** : un jet de couleur (bleu, jaune, rouge) traverse une valve, ce qui visualise le flux sanguin et ses turbulences.

1.7. Les situations qui doivent alerter (diapositive n°10)

• **Dyspnée aiguë ou œdème pulmonaire** : penser à une **fuite aiguë**, surtout en cas d'hypotension.

• **Syncope ou angor d'effort** : rechercher notamment un **rétrécissement aortique sévère**.

• **Fièvre + souffle, ou fièvre chez un porteur de prothèse** : évoquer une **endocardite** et organiser une évaluation urgente.

• **Instabilité hémodynamique** : prise en charge hospitalière immédiate.

[Dit à l'oral] Une valve malade crée un flux turbulent (le flux normal ne l'est pas) : une bactérie circulante peut s'y fixer et provoquer une endocardite, dont la mortalité est d'environ 25 %. Le patient doit éviter tout risque infectieux et ne pas prendre d'antibiotiques sans avis, surtout s'il a été opéré d'une valve. Les infections dentaires peuvent entraîner une infection systémique : soins dentaires au moins 2 fois par an.

Partie 2 — Le rétrécissement aortique (diapositives n°11 à 18)

[Dit à l'oral] Image du professeur : dans le rétrécissement aortique, le ventricule gauche est un **« bodybuilder »** : il pousse contre un obstacle, se muscle et s'hypertrophie.

2.1. Cas clinique : une syncope dans les escaliers (diapositive n°11)

Cas pédagogique fictif : patient de **78 ans**, **dyspnée d'effort**, **syncope en montant 2 étages**, **souffle systolique rude au foyer aortique irradiant aux carotides**. Diagnostic à évoquer : **rétrécissement aortique**. Examen à demander rapidement : **échocardiographie**.

[Dit à l'oral] Le patient aurait pu être pris en charge plus tôt, dès le stade de dyspnée. La syncope traduit un bas débit cérébral à l'effort. Un rétrécissement aortique sévère calcifié donne un souffle très bruyant et râpeux. Facteurs de risque cités : sédentarité, tabagisme, hypercholestérolémie, facteur familial (prévalence notable en Bretagne).

2.2. Physiopathologie : le ventricule gauche éjecte contre un obstacle (diapositive n°12)

La **pression systolique du ventricule gauche augmente** et le **ventricule gauche s'hypertrophie**. L'hypertrophie maintient d'abord la fonction ; puis le **remplissage devient difficile** (ventricule moins compliant), et une **défaillance** est possible. **[Dit à l'oral]** Au début, la valve se calcifie un peu comme une plaque d'athérome ; à un stade avancé, la paroi qui a trop poussé se fibrose.

À retenir : **rétrécissement aortique = surcharge de pression → hypertrophie plutôt concentrique**.

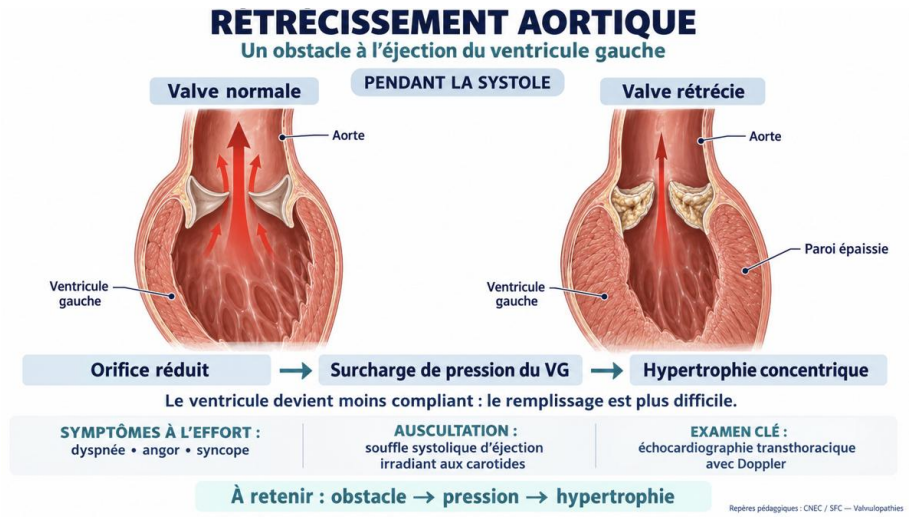


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : schéma comparant, pendant la systole, une **valve aortique normale** (le sang passe largement) et une **valve rétrécie**, calcifiée (le jet est étroit et la **paroi du ventricule gauche est épaissie**). Bandeau : **orifice réduit → surcharge de pression du ventricule gauche → hypertrophie concentrique** ; le ventricule devient moins compliant et se remplit plus difficilement. Encadrés : symptômes à l'effort (dyspnée, angor, syncope), auscultation (souffle systolique d'éjection irradiant aux carotides), examen clé (échocardiographie transthoracique avec Doppler). « À retenir : obstacle → pression → hypertrophie ».

2.3. Le trio clinique (diapositive n°13)

[Insistance d'un intervenant] • **Dyspnée d'effort** : le symptôme le plus fréquent, à rechercher activement.

• **Angor d'effort** : possible **même sans coronaropathie** ; **[Dit à l'oral]** le ventricule hypertrophié a des besoins en oxygène accrus, d'où une inadéquation entre besoins et apports.

• **Syncope d'effort** : un **signal d'alarme** ; **[Dit à l'oral]** à l'effort, l'obstacle empêche le débit d'augmenter, d'où une hypoperfusion cérébrale.

Souffle : **systolique d'éjection, rude, irradiant aux carotides**.

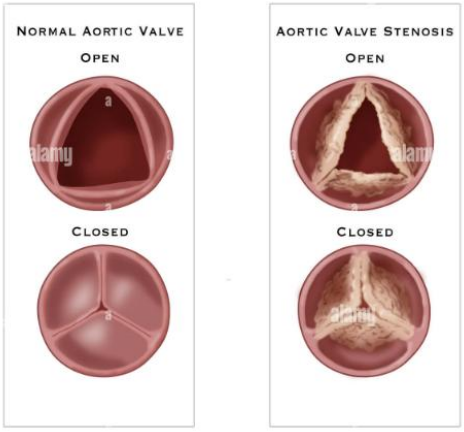


Figure — diapositive n°13

Description du schéma (diapositive n°13) : valve aortique vue de face, ouverte et fermée : à gauche une **valve normale** (3 cuspides fines, large ouverture), à droite une **valve sténosée** (cuspides épaisses et calcifiées, ouverture réduite).

2.4. Diagnostic échographique (diapositives n°14 et 15)

On recherche la **mobilité** de la valve, ses **calcifications**, son **ouverture**, puis on réalise les **mesures Doppler**.

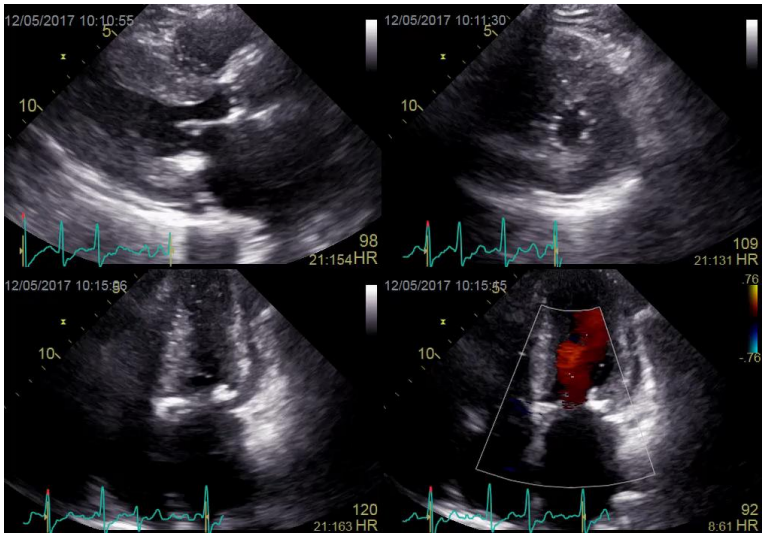


Figure — diapositive n°14

Description du schéma (diapositive n°14) : 4 images d'échocardiographie de la valve aortique (coupes en 2 dimensions et Doppler couleur) : on y apprécie la mobilité, les calcifications et l'ouverture de la valve.

Repères Doppler du **rétrécissement aortique sévère à haut gradient** : **vitesse maximale ≥ 4 mètres par seconde** ; **gradient moyen ≥ 40 millimètres de mercure** ; **surface valvulaire ≤ 1 centimètre carré**. Ces paramètres s'interprètent ensemble ; en cas de **discordance**, il faut **vérifier les mesures et le débit**.

[Vigilance] Un faible gradient n'exclut pas un rétrécissement aortique sévère si le débit est bas.

[Dit à l'oral] Une surface inférieure à 1 centimètre carré est grave, mais en l'absence de symptômes associés, la situation peut être surveillée.

2.5. Prise en charge (diapositives n°16 et 17)

Correction du cas : syncope d'effort + souffle évocateur imposent une **échocardiographie rapidement**. Si le rétrécissement aortique sévère est confirmé, une **évaluation spécialisée pour remplacement valvulaire** s'impose.

[Vigilance] Un traitement symptomatique seul ne corrige pas l'obstacle. Un rétrécissement aortique sévère symptomatique fait discuter une intervention sans attendre la défaillance.

2 options : la **chirurgie** (remplacement valvulaire par une prothèse) et le **TAVI** (implantation d'une **bioprothèse par cathéter**). Le choix est **partagé** : anatomie, risque opératoire, espérance de vie et préférences du patient. La **Heart Team** propose la stratégie avec le patient.



Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : 3 prothèses : une **bioprothèse implantée par cathéter** (armature métallique en treillis), une **prothèse mécanique** à 2 ailettes, et une **bioprothèse chirurgicale** à 3 feuillets montés sur une armature (légendes en anglais décrivant sa conception).

[Dit à l'oral] La valve biologique, d'origine porcine ou bovine, a une durée de vie limitée et dégénère à partir de **10 à 15 ans**. La valve mécanique ne dégénère pas mais impose des anticoagulants à vie et un suivi régulier. Chez le patient âgé, la valve biologique (TAVI) est généralement préférée ; chez le sujet jeune, la valve mécanique évite des réinterventions tous les 10 à 15 ans.

2.6. Bicuspidie : regarder aussi l'aorte (diapositive n°18)

[Dit à l'oral] Une seule diapositive cette année. La **bicuspidie** est une valve aortique à **2 cuspides au lieu de 3**. Elle peut entraîner une **sténose, une fuite, ou les 2**. Elle est **parfois familiale** : il faut **évaluer l'aorte** et envisager le **dépistage des apparentés**. Elle peut aussi entraîner une dilatation de l'aorte ascendante.

[Vigilance] En cas de bicuspidie, on surveille la valve ET l'aorte ; les seuils dépendent du contexte.

[Correction] Les notes indiquent que la bicuspidie « atteint 5 à 10 % de la population ». Les sources donnent environ 1 à 2 % de la population (certaines études récentes moins de 1 %).

[Incertain] Les notes parlent d'une « prévalence de 30 % » dans les familles. Les sources rapportent une fréquence d'environ 9 % chez les apparentés au 1er degré, et une agrégation familiale dans environ 1/3 des familles étudiées : la signification exacte du chiffre de 30 % n'est pas claire.

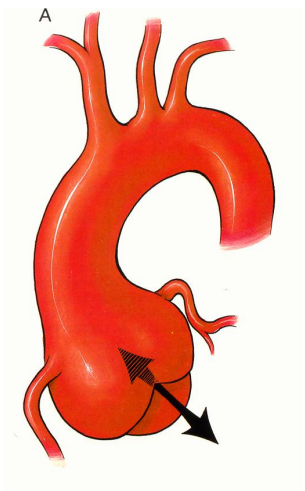


Figure — diapositive n°18

Description du schéma (diapositive n°18) : dessin de l'**aorte** (racine, aorte ascendante, crosse et aorte descendante) avec une flèche noire indiquant un diamètre mesuré : la surveillance porte aussi sur le **calibre de l'aorte**.

Partie 3 — L'insuffisance aortique (diapositives n°19 à 24)

3.1. Cas clinique : une pression à 130/45 (diapositive n°19)

Cas pédagogique fictif : patient de **40 ans**, **fatigue à l'effort**, **souffle diastolique décroissant**, pression artérielle à **130/45 millimètres de mercure**. Une **fuite aortique** est suspectée. Question : la pression diastolique suffit-elle à décider d'une opération ?

[Dit à l'oral] Le pouls est très ample. Historiquement, des patients atteints de syphilis cardiovasculaire avaient la tête animée de mouvements rythmiques (**signe de Musset**) : il s'agissait d'une insuffisance aortique sévère avec un pouls très ample.

3.2. Physiopathologie (diapositive n°20)

La **fuite aortique survient en diastole**, de l'**aorte vers le ventricule gauche** : la valve ne ferme pas complètement. Le ventricule gauche reçoit le remplissage normal (venu de l'oreillette gauche par la valve mitrale) **et** le volume qui revient de l'aorte.

À retenir : **insuffisance aortique chronique = surcharge de volume → dilatation du ventricule gauche**. **[Dit à l'oral]** Image du professeur : le ventricule gauche est une **« danseuse étoile »**, aussi musclée que le bodybuilder mais autrement : il se dilate au lieu de s'hypertrophier.

3.3. Causes (diapositive n°21)

• **Valve anormale** : bicuspidie, dégénérescence, endocardite.

• **Racine aortique dilatée** : la fermeture des cuspides devient incomplète.

• **Installation aiguë** : **endocardite ou dissection**, à rechercher en urgence. Dans l'**insuffisance aortique aiguë**, le ventricule gauche **n'a pas eu le temps de s'adapter**.

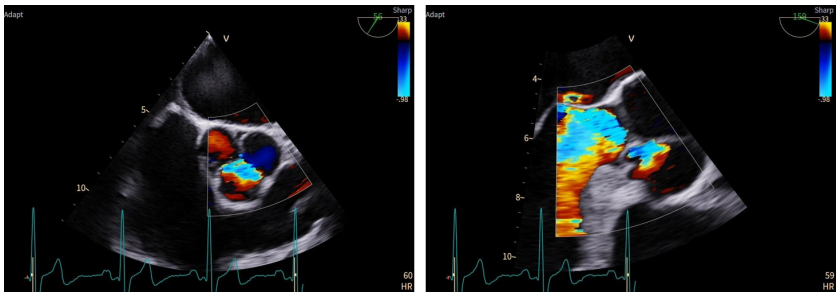


Figure — diapositive n°21

Description du schéma (diapositive n°21) : 2 images d'échocardiographie avec **Doppler couleur** montrant un flux régurgitant aortique (jet coloré dans la chambre de chasse du ventricule gauche).

3.4. Observer une régurgitation aortique (diapositive n°22)

Question : à quel moment le flux revient-il dans le ventricule gauche ? Réponse : en **diastole**. Le **Doppler couleur montre le flux** ; **plusieurs mesures concordantes évaluent la sévérité**. L'échocardiographie recherche la cause, la sévérité, le retentissement (dilatation et fonction du ventricule gauche) et les dimensions de l'aorte.

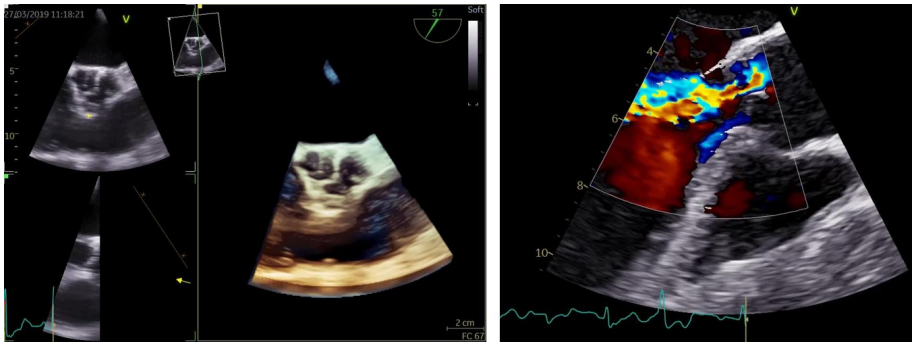


Figure — diapositive n°22

Description du schéma (diapositive n°22) : à gauche, une vue de la **valve aortique** en échocardiographie (dont une vue en 3 dimensions) ; à droite, un **jet de régurgitation** en Doppler couleur, de l'aorte vers le ventricule gauche.

3.5. Quand traiter ? (diapositives n°23 et 24)

• **Symptômes attribuables à une insuffisance aortique sévère** : évaluer une intervention.

• **Retentissement sur le ventricule gauche** (dilatation ou baisse de fonction) : ne pas attendre trop longtemps.

• **Aorte associée** : son évolution peut modifier la stratégie.

Selon la diapositive n°23, **l'indication repose sur un ensemble de critères, pas sur la seule pression diastolique**. Correction du cas (diapositive n°24) : la **pression pulsée est large** ; c'est un **indice clinique, pas une indication opératoire**. Il faut une **échocardiographie** (confirmer la fuite, sa sévérité, son mécanisme) et **évaluer le patient** (symptômes réels, taille et fonction du ventricule gauche, dimensions aortiques). Surveiller ou intervenir : décision fondée sur le bilan complet.

[Incertain] Désaccord majeur. Les diapositives n°24 et n°40 répondent « non » : 130/45 ne suffit pas pour opérer. Les notes rapportent qu'à l'oral, le professeur a répondu « oui, une pression diastolique à 45 millimètres de mercure suffit pour opérer », en annonçant qu'il corrigerait sa diapositive, et l'a illustré par une anecdote d'externat ; il a aussi dit qu'une

fuite aortique sévère de ce type doit être opérée en urgence. Selon les recommandations européennes, les indications chirurgicales reposent sur les symptômes, une fraction d'éjection du ventricule gauche ≤ 50 % ou un diamètre télésystolique du ventricule gauche > 50 millimètres (ou > 25 millimètres par mètre carré) ; la pression diastolique n'en fait pas partie, même si une pression diastolique très basse témoigne d'une fuite importante. Version à confirmer avec l'enseignant avant l'examen.

Partie 4 — L'insuffisance mitrale (diapositives n°25 à 32)

[Vigilance] La prise de notes est incomplète à cet endroit : la fin de la partie sur l'insuffisance aortique et le début de celle sur l'insuffisance mitrale manquent. Les passages concernés reposent sur les diapositives.

4.1. Cas clinique : un souffle à la pointe (diapositive n°25)

Cas pédagogique fictif : patient de **62 ans**, **dyspnée progressive**, **palpitations depuis 1 semaine**, **souffle holosystolique apical irradiant à l'aisselle**, **pouls irrégulier**. Valve suspectée : **insuffisance mitrale**. Trouble du rythme à rechercher : **fibrillation atriale**. **[Dit à l'oral]** Les 2 signes clés de l'insuffisance mitrale sont la dyspnée et les palpitations ; il n'y a ni angor ni syncope.

4.2. Physiopathologie (diapositive n°26)

La **fuite mitrale survient en systole**, du **ventricule gauche vers l'oreillette gauche** : pendant l'éjection, une partie du volume retourne vers l'oreillette gauche, et le **débit vers l'aorte peut diminuer**. À retenir : **insuffisance mitrale = régurgitation systolique ; chronique : dilatation de l'oreillette gauche et du ventricule gauche**.

[Dit à l'oral] Image du professeur : le ventricule gauche est « **feignant** » : il dispose de 2 portes de sortie (mitrale et aortique) sans travailler davantage. Après l'opération, il perd cette 2e sortie et peut présenter une dysfonction : il faut opérer avant que le cœur ne soit trop dilaté.

4.3. Insuffisance mitrale primaire ou secondaire (diapositive n°27)

	Insuffisance mitrale primaire	**Insuffisance mitrale secondaire**
Origine	Lésion de la valve ou des cordages	Remodelage du ventricule gauche ou de l'oreillette gauche
Exemples	Prolapsus, rupture de cordage, endocardite	Cardiomyopathie, ischémie, dilatation atriale
Logique du traitement	Corriger la lésion si indiqué	Traiter la cardiopathie ; discuter la valve

Même fuite, mais **mécanismes et stratégies différents**. Dans l'**insuffisance mitrale secondaire**, le cœur est malade : le débit et les pressions sont modifiés, et le **souffle peut être peu intense malgré une fuite importante**.

[Insistance d'un intervenant] [Vigilance] Un souffle faible n'exclut pas une fuite sévère.

[Incertain] Les notes qualifient l'insuffisance mitrale primaire de « rare (5 %) » et la secondaire de liée au vieillissement du cœur. Les sources indiquent au contraire que les étiologies dégénératives (primaires) représentent environ 70 % des insuffisances mitrales.

Chiffre à vérifier.

4.4. Clinique et diagnostic (diapositive n°28)

• **Souffle évocateur** : holosystolique, à la pointe, souvent vers l'aisselle.

• **Électrocardiogramme** : un pouls irrégulier fait rechercher une **fibrillation atriale**.

• **Échocardiographie** : cause, sévérité, taille de l'oreillette gauche et du ventricule gauche, fonction et pressions pulmonaires.

[Vigilance] Un souffle faible peut accompagner une insuffisance mitrale importante.

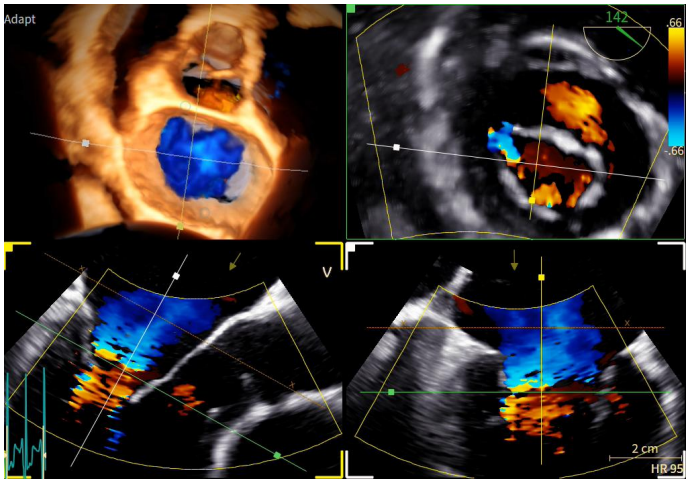


Figure — diapositive n°28

Description du schéma (diapositive n°28) : 4 vues d'échocardiographie de la **valve mitrale** : une reconstruction en 3 dimensions de la valve vue de face et 3 coupes avec **Doppler couleur** montrant le jet de fuite.

4.5. Observer une fuite mitrale (diapositive n°29)

Questions : où va le jet ? Que regarde-t-on en plus du jet ? **Mécanisme, quantification et retentissement** restent tous les 3 nécessaires.

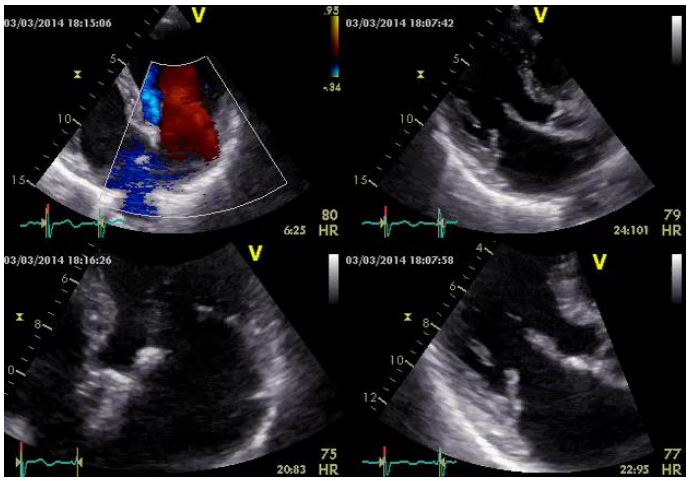


Figure — diapositive n°29

Description du schéma (diapositive n°29) : 4 images d'échocardiographie : un **jet de régurgitation mitrale** en Doppler couleur dirigé vers l'oreillette gauche, et des coupes en 2 dimensions de la valve.

4.6. Insuffisance mitrale sévère : 60 % peut déjà alerter (diapositive n°30)

Dans une insuffisance mitrale sévère, une **fraction d'éjection du ventricule gauche à 60 %** n'est **pas forcément rassurante** : une partie du volume est éjectée vers l'oreillette gauche, et la fraction d'éjection totale peut **surestimer la performance utile**. Dans l'insuffisance mitrale primaire sévère, on suit les **symptômes**, le **ventricule gauche**, la **fibrillation atriale** et les **pressions pulmonaires**.

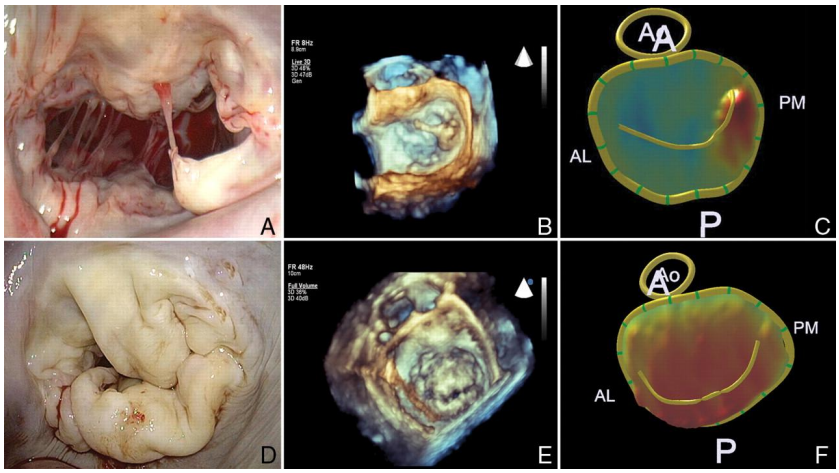


Figure — diapositive n°30

Description du schéma (diapositive n°30) : planche de 6 images : vues chirurgicales (A et D) d'une **valve mitrale dégénérative** avec prolapsus et tissu valvulaire en excès, reconstructions échographiques en 3 dimensions de la valve vue de face (B et E), et modèles colorés de la valve (C et F) avec les repères des feuillets antérieur et postérieur. **[Dit à l'oral]** Une **valve myxoïde** entraîne prolapsus et fuite mitrale.

4.7. Insuffisance mitrale aiguë (diapositive n°31)

Causes : **rupture de cordage ou de pilier** (fuite importante brutale) ; **endocardite** (destruction valvulaire). Conséquences : **œdème aigu du poumon, hypotension** : échocardiographie et prise en charge spécialisée **en urgence**.

[Vigilance] Absence de dilatation ≠ absence de gravité : dans l'insuffisance mitrale aiguë, le cœur n'a pas eu le temps de se dilater.

4.8. Réparer la mitrale quand c'est possible (diapositive n°32)

• **Insuffisance mitrale primaire sévère** : **réparation chirurgicale privilégiée** si elle peut être durable. **[Dit à l'oral]** Réparer plutôt que remplacer redonne une espérance de vie normale.

• **Risque opératoire élevé** : une **réparation par cathéter** peut être proposée à certains patients.

• **Insuffisance mitrale secondaire** : traitement de la cardiopathie, puis sélection d'une intervention si besoin.

Le bon moment compte autant que la technique.

Partie 5 — Autres valvulopathies (diapositives n°33 et 34)

5.1. Rétrécissement mitral : pression en amont (diapositive n°33)

Le **rétrécissement mitral** crée un **obstacle au remplissage du ventricule gauche** : la **pression augmente dans l'oreillette gauche puis dans la circulation pulmonaire**. Clinique : **dyspnée** ; **roulement diastolique à la pointe**. Complications : **fibrillation atriale** et **risque thromboembolique**. Le ventricule gauche n'est pas soumis à la même surcharge de pression que dans le rétrécissement aortique.

5.2. Fuite tricuspide : penser au cœur droit (diapositive n°34)

La **fuite tricuspide** est une **régurgitation systolique du ventricule droit vers l'oreillette droite**. Elle entraîne une **congestion systémique** : œdèmes, turgescence jugulaire, hépatomégalie, parfois ascite. Il faut aussi **évaluer le ventricule droit** : mécanisme, sévérité, retentissement et pressions pulmonaires.

[Vigilance] Une fuite tricuspide sévère n'est pas banale : elle mérite une évaluation dédiée.

Partie 6 — Soins et suivi (diapositives n°35 à 37)

6.1. Endocardite : prévention et vigilance (diapositive n°35)

Prévenir : hygiène bucco-dentaire et soins réguliers. **Repérer** : une **fièvre persistante**, surtout chez un porteur de prothèse ou en cas d'antécédent d'endocardite. **Agir** : **hémocultures et échocardiographie rapidement** en cas de suspicion. Une **antibioprophylaxie** concerne les **patients à haut risque** lors de **gestes dentaires à risque**, selon les recommandations.

6.2. Après un remplacement valvulaire (diapositive n°36)

• **Prothèse mécanique** : **antivitamine K à vie**, suivi de l'**INR**.

• **Bioprothèse** : **durabilité limitée**, surveillance clinique et échographique.

• Pour toutes les prothèses : informer le patient, prévenir l'endocardite, repérer une dysfonction.

[Vigilance] Les anticoagulants oraux directs sont contre-indiqués avec une valve mécanique.

6.3. Un suivi actif (diapositive n°37)

Interroger à nouveau (capacité d'effort, symptômes, palpitations, épisodes de fièvre), **comparer les échographies** (sévérité, évolution des dimensions et de la fonction) et **donner une conduite à tenir** (qui contacter, quels symptômes imposent une consultation rapide). **Un symptôme nouveau fait réévaluer la situation avant le prochain rendez-vous prévu**.

Partie 7 — À retenir et autoévaluation (diapositives n°38 à 41)

Lésion	Temps du souffle	Retentissement clé
Rétrécissement aortique	Systole	Pression du ventricule gauche → hypertrophie
Insuffisance aortique	Diastole	Volume du ventricule gauche → dilatation
Insuffisance mitrale	Systole	Volume de l'oreillette gauche et du ventricule gauche → dilatation ; fibrillation atriale
Rétrécissement mitral	Diastole	Pression de l'oreillette gauche → congestion pulmonaire

Le mécanisme explique le souffle et les conséquences. Synthèse des notes : rétrécissement aortique (obstacle systolique, hypertrophie, dyspnée, angor, syncope, souffle systolique rude vers les carotides, échocardiographie, intervention si sévère symptomatique) ; insuffisance aortique (fuite diastolique, dilatation, souffle diastolique décroissant, pression pulsée large, décision selon symptômes, ventricule gauche, aorte et sévérité) ; insuffisance mitrale (fuite systolique, dilatation de l'oreillette et du ventricule gauches, dyspnée et palpitations, souffle holosystolique apical vers l'aisselle, rechercher une fibrillation atriale, réparer si possible) ; rétrécissement mitral (obstacle diastolique, pression de l'oreillette gauche, congestion pulmonaire, roulement diastolique, fibrillation atriale, risque thromboembolique) ; fuite tricuspide (congestion systémique, évaluer le ventricule droit et les pressions pulmonaires).

[Dit à l'oral] Moyens mnémotechniques : ventricule gauche « bodybuilder » (rétrécissement aortique, hypertrophie), « danseuse étoile » (insuffisance aortique, dilatation), « feignant » (insuffisance mitrale, 2 sorties) ; pression en amont dans le rétrécissement mitral.

Autoévaluation (diapositives n°39 et 40)

1) Une insuffisance mitrale donne-t-elle une fuite en systole ou en diastole ? **Systole** : le ventricule gauche éjecte aussi vers l'oreillette gauche.

2) Un souffle peu intense exclut-il une fuite sévère ? **Non** : le souffle dépend du débit et des pressions.

3) Une pression diastolique à 45 millimètres de mercure suffit-elle pour opérer une insuffisance aortique ? Diapositive : **non** (symptômes, échocardiographie, ventricule gauche et aorte guident la décision). [Incertain] À l'oral, réponse « oui » selon les notes : voir le point 3.5, à confirmer avec l'enseignant.

4) Quel examen confirme une valvulopathie suspectée ? L'**échocardiographie transthoracique** : cause, sévérité, retentissement. Décrire un souffle oriente ; **l'échographie confirme et mesure**.

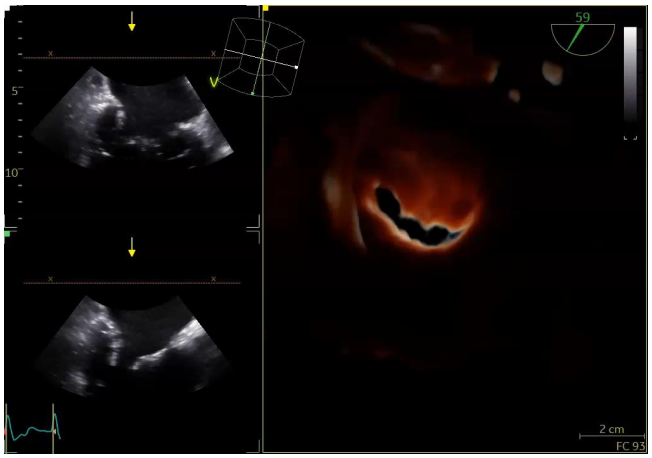


Figure — diapositive n°41

Description du schéma (diapositive n°41) : image d'échocardiographie en 3 dimensions : à gauche 2 coupes de repérage, à droite une **valve vue de face** en rendu volumique, avec son orifice. Message de la diapositive : « **écouter le patient avant d'écouter son souffle** » ; demander ce qu'il ne fait plus, situer le souffle, chercher le retentissement, savoir quand demander de l'aide.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Pression diastolique à 45 mmHg et indication opératoire	Oral : « oui, suffit pour opérer »	Diapositives n°24 et 40 : non ; sources : critères = symptômes, fraction d'éjection, diamètres du ventricule gauche	Non tranché ([Incertain])
Prévalence de la bicuspidie	5 à 10 % de la population	Sources : 1 à 2 %	1 à 2 % ([Correction])
Bicuspidie familiale	« Prévalence de 30 % »	Sources : environ 9 % des apparentés au 1er degré	Non tranché ([Incertain])
Fréquence de l'insuffisance mitrale primaire	« Rare, 5 % »	Sources : étiologies dégénératives environ 70 %	Non tranché ([Incertain])
Notes incomplètes	Passage manquant (fin insuffisance aortique, début insuffisance mitrale)	Diapositives n°23 à 26	Diapositives ([Vigilance])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
B1, B2	1er et 2e bruits du cœur
ECG	Électrocardiogramme
ETT	Échocardiographie transthoracique
FA	Fibrillation atriale
FEVG	Fraction d'éjection du ventricule gauche
IA	Insuffisance aortique
IC	Insuffisance cardiaque
IM	Insuffisance mitrale
INR	International normalized ratio (rapport normalisé international)
IT	Insuffisance (fuite) tricuspide
OAP	Œdème aigu du poumon
OD, OG	Oreillette droite, oreillette gauche
RA	Rétrécissement aortique
RM	Rétrécissement mitral
RVOT	Chambre de chasse du ventricule droit (right ventricular outflow tract)
TAVI	Implantation valvulaire aortique par cathéter (transcatheter aortic valve implantation)
VD, VG	Ventricule droit, ventricule gauche